

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13408583	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 25/08/25 11:39
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0043203635^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : CARRERAS, MATIAS JAVIER	

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
HEMATOLOGIA			
Hemograma			
Tipo de muestra: Sangre entera con EDTA			
Recuento de Glóbulos Blancos	1.3	10 ³ /μL	4.0 - 10.0 10 ³ /μL
Método: Citometría de flujo fluorescente			
Recuento de Glóbulos Rojos	2.3	10 ⁶ /μL	4.5 - 5.5 10 ⁶ /μL
Método: Corriente directa y enfoque hidrodinámico			
Hemoglobina	6.6	g/dL	13.0 - 17.0 g/dL
Método: SLS libre de cianuro			
Hematocrito	19	%	40 - 50 %
Método: Corriente directa y enfoque hidrodinámico			
Valor crítico informado			
V.C.M.	84	fl	83 - 101 fl
H.C.M.	29	pg	27 - 32 pg
C.H.C.M.	35	g/dL	31 - 36 g/dL
R.D.W.	14.2	%	11.6 - 14.0 %
Fórmula Leucocitaria Porcentual			
Neutrófilos	22.7	%	40 - 80 %
Método: Citometría de flujo fluorescente			
Eosinófilos	0.0	%	1 - 6 %
Método: Citometría de flujo fluorescente			
Basófilos	0.0	%	0.0 - 2.0 %
Método: Citometría de flujo fluorescente			
Linfocitos	71.2	%	20 - 40 %
Método: Citometría de flujo fluorescente			
Monocitos	6.1	%	2 - 10 %
Método: Citometría de flujo fluorescente			
Formula Leucocitaria Absoluta			
Rto absoluto de Neutrófilos	0.3	10 ³ /μL	2.0 - 7.0 10 ³ /μL
Rto absoluto de Eosinófilos	0.0	10 ³ /μL	0.0 - 0.5 10 ³ /μL
Rto absoluto de Basófilos	0.0	10 ³ /μL	0,0 - 0,1 10 ³ /μL

HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N°	: 13408583	OP	Fecha Recepción	: 25/08/25 11:39	
Paciente	: ADER, MANUEL		Episodio/Movim.	: 0043203635^0001	
DNI	: 45683086	Fecha de nacimiento	: 26/04/2004	Historia Clínica	: 0002201988
Solicitado por	: CARRERAS, MATIAS JAVIER				

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
HEMATOLOGIA			
Rto absoluto de Linfocitos	0.9	10 ³ /μL	1.0 - 3.0 10 ³ /μL
Rto absoluto de Monocitos	0.1	10 ³ /μL	0.2 - 1.0 10 ³ /μL
Recuento de plaquetas	11000	/μL	150000 - 410000 /μL
Método: Corriente directa y enfoque hidrodinámico			
QUIMICA CLINICA			
Sodio plasmático	141	mEq/L	136 - 145 mEq/L
Método: ISE indirecto			
Potasio plasmático	3.6	mEq/L	3.5 - 5.1 mEq/L
Método: ISE indirecto			
Urea plasmática	52	mg/dL	13 - 43 mg/dL
Método: Ureasa.			
A partir de Septiembre 2023 se ha modificado la metodología empleada y el intervalo de referencia			
Creatinina plasmática	0.63	mg/dL	0.73 - 1.18 mg/dL
Método: Enzimático			

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13408583	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 25/08/25 11:39
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0043203635^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : CARRERAS, MATIAS JAVIER	

Resultados	Unidades	Valores de Referencia
QUIMICA CLINICA		

Tasa de filtrado glomerular estimado

Método: Fórmula CKD-EPI

Tasa de filtrado glomerular estimado	139	mL/min/1.73 m ²	Mayor a 90 ml/min.
			60-89 ml/min: filtrado glomerular levemente disminuido. 30-59 ml/min: filtrado glomerular moderadamente disminuido. 15-29 ml/min: filtrado glomerular severamente disminuido. Menor a 15 ml/min: insuficiencia renal terminal.

La tasa de filtrado glomerular estimada no puede ser utilizada en pacientes: Menores de 18 años o mayores de 70 años, embarazadas, amputados, BMI menor a 18 o mayor a 40, dietas especiales, medicación nefrotóxica, pacientes con síndrome nefrótico.

Acido Urico plasmático	4.1	mg/dL	3.7 - 7.7 mg/dL
Método: Uricasa			
Calcio plasmático	9.4	mg/dL	8.4 - 10.2 mg/dL
Método: Arsenazo III			
Fósforo plasmático	3.5	mg/dL	2.3 - 4.7 mg/dL
Método: Fosfomolibdato			
Magnesio plasmático	1.6	mg/dL	1.6 - 2.6 mg/dL
Método: Enzimático			
L.D.H. / Lactato deshidrogenasa plasmática	115	U/L	125 - 220 U/L
Método: Lactato a piruvato			
A partir del 12 de Junio de 2026 la muestra utilizada es suero.			
G.G.T. / Gammaglutamil transferasa plasmática	67	U/L	12 - 64 U/L
Método: G-glutamyl-3-carboxi-4-nitroanilida			

**HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL**

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N° : 13408583	OP
Paciente : ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 25/08/25 11:39
DNI : 45683086	Episodio/Movim. : 0043203635^0001
Fecha de nacimiento : 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por : CARRERAS, MATIAS JAVIER	

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
--	------------	----------	-----------------------

QUIMICA CLINICA

Hepatograma

Colesterol Total plasmático Método: Enzimático	134	mg/dL	Menor a 200 mg/dL
A.S.T. / Aspartato aminotransferasa plasmática Método: NADH sin piridoxal	22	U/L	5 - 34 U/L
A.L.T. / Alanina aminotransferasa plasmática Método: NADH sin piridoxal	59	U/L	Menor a 55 U/L
Bilirrubina Total plasmática Método: Sal de diazonio	0.3	mg/dL	0.2 - 1.2 mg/dL
Fosfatasa Alcalina plasmática Método: Para-nitrofenil fosfato	95	U/L	40 - 150 U/L

PROTEINAS

Determinación de:

Inmunoglobulina G plasmática Método: Inmunoturbidimetría	961	mg/dL	540 - 1822 mg/dL
---	-----	-------	------------------

SEROLOGIA

HTLV I/II Ac IgG Método: EQLIA	Suero No Reactivo	
Chagas Elisa Lisado Método: ELISA	Suero No Reactivo	
Chagas HAI Método: Hemoaglutinación indirecta	Suero No Reactivo	Mayor a 1/32: Positivo
Chagas IFI Método: Inmunofluorescencia indirecta	Suero No Reactivo	Mayor a 1/16: Positivo

HOSPITAL BRITANICO
LABORATORIO CENTRAL

Jefe de Laboratorio: Bioq. Muryan Alexis MN: 6911

Protocolo N°	: 13408583	OP
Paciente	: ADER, MANUEL	Fecha Recepción : 25/08/25 11:39
DNI	: 45683086	Episodio/Movim. : 0043203635^0001
Fecha de nacimiento	: 26/04/2004	Historia Clínica : 0002201988
Solicitado por	: CARRERAS, MATIAS JAVIER	

	Resultados	Unidades	Valores de Referencia
SEROLOGIA			
Varicela Zoster IgG Método: QLIA	2.3	COI	Suero Reactivo
Herpes Simplex 1 IgG Método: QLIA	24.5	COI	Suero Reactivo
Herpes Simplex 2 IgG Método: QLIA	Suero No Reactivo		
Brucelosis Método: Rosa de Bengala	Suero No Reactivo		

A partir de Agosto 2025 se ha modificado la expresión de ciertas unidades para adecuarlas al idioma castellano, sin verse afectados los resultados informados.

Fecha de impresión: 10/09/2026 10:14